



El INE registra 3.808 suicidios en 2025, un convenio del Ministerio del Interior refuerza el bienestar psicológico de sus empleados y una revisión en Nature Reviews Psychology replantea la hiperacusia y la misofonía: claves del 11 de agosto de 2026

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Instituto Nacional de Estadística sitúa en 3.808 los suicidios registrados en 2025, un 3,7 % menos que el año anterior, aunque los propios datos son provisionales y podrían estar subestimados. El BOE publica un convenio entre el Ministerio del Interior, el Consejo General de la Psicología y el Colegio Oficial de Madrid para promover el bienestar psicológico del personal de los servicios centrales del ministerio. Un estudio de la Universidad de Barcelona explora la autocaracterización como herramienta para evaluar el cambio identitario durante la psicoterapia. Una revisión publicada en Nature Reviews Psychology propone entender la hiperacusia y la misofonía desde un enfoque transdiagnóstico compartido.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El INE registra 3.808 suicidios en 2025, un 3,7 % menos que el año anterior, según datos provisionales

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte correspondiente a 2025, con datos aún provisionales. Según esta publicación, en 2025 se registraron 19.042 fallecimientos por causas externas en España, 691 más que el año anterior, de los cuales 3.808 corresponden a suicidios, un 3,7 % menos que en 2024. El suicidio se sitúa así en tercer lugar entre las causas externas de muerte, por detrás de las caídas accidentales (4.814 fallecidos, un 8,2 % más que el año anterior) y del ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales (3.899 fallecimientos, un 6,7 % más). Entre los hombres, el suicidio continúa siendo la primera causa de muerte externa, con 2.784 fallecidos, por delante de las caídas accidentales; entre las mujeres, las caídas accidentales ocupan el primer lugar. El propio INE advierte de que las cifras provisionales de fallecimientos por causas externas podrían estar subestimadas, ya que los resultados de las autopsias requieren más tiempo que en las muertes naturales; los datos definitivos no se conocerán hasta diciembre de 2026. De hecho, la cifra provisional de 2024 (3.846 suicidios) se elevó posteriormente a 3.953 en la cifra definitiva. En este contexto, España cuenta desde febrero de 2025 con el primer Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que contempla la creación de un Observatorio estatal para la Prevención del Suicidio, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2026, entre otras medidas de coordinación intersectorial, detección precoz y formación especializada.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), difundido por Infocop

NORMATIVA · NACIONAL

El BOE publica un convenio entre Interior, el Consejo General de la Psicología y el COP Madrid para promover el bienestar psicológico de los empleados públicos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución de 6 de julio de 2026 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior por la que se hace público el convenio suscrito el 3 de julio de 2026 entre la Subsecretaría de

Interior, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. El objeto del convenio es establecer la colaboración entre las tres entidades para promover actividades de información, sensibilización, divulgación y prevención en materia de bienestar psicológico dirigidas al personal de los servicios centrales del Ministerio del Interior. Entre los compromisos asumidos, el Ministerio se compromete a facilitar herramientas de comunicación interna y a dar visibilidad a las actuaciones del Consejo General de la Psicología y del Colegio de Madrid, mientras que estas corporaciones se comprometen a poner a disposición documentos y materiales técnicos, identificar a profesionales cualificados para actividades de sensibilización y ejecutar seminarios y jornadas informativas. El convenio no comporta ninguna aportación económica para ninguna de las partes; los gastos derivados de las actuaciones se financiarán con cargo a los presupuestos ordinarios de cada entidad, en función de su disponibilidad presupuestaria. Para el seguimiento del acuerdo se constituirá una Comisión Mixta con tres representantes de cada parte. El convenio tendrá una duración de cuatro años desde que adquiera eficacia, prorrogable por un periodo adicional de hasta cuatro años más si las partes lo acuerdan unánimemente.

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE), Ministerio del Interior

CLÍNICA · NACIONAL

Un estudio de la Universidad de Barcelona explora la autocaracterización para evaluar el cambio identitario durante la psicoterapia

Un estudio publicado en la Revista de Psicoterapia por Juan Francisco Narváez-Villarreal y Guillem Feixas, de la Universitat de Barcelona, examina el potencial de la autocaracterización, una técnica narrativa propuesta por George A. Kelly dentro de la Teoría de los Constructos Personales, para evaluar el cambio identitario a lo largo de un proceso psicoterapéutico. La técnica consiste en pedir a la persona que redacte una descripción de sí misma en tercera persona, como si un amigo cercano describiera al protagonista de una obra de teatro, favoreciendo así el autodistanciamiento y la reflexión sobre la propia identidad. Los autores compararon las autocaracterizaciones realizadas al inicio y al final del tratamiento por dos mujeres jóvenes con ansiedad y depresión que participaron en una terapia transdiagnóstica basada en la

identidad, combinando un análisis narrativo inspirado en la propuesta original de Kelly con una lectura complementaria basada en el modelo de personalidad HEXACO. En una de las participantes, la narrativa pasó de reflejar una marcada división entre la imagen mostrada a los demás y la experiencia interna a una identidad más integrada, con una reducción paralela del malestar psicológico y de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés. La segunda participante mostró cambios más sutiles, con un mayor reconocimiento de su sufrimiento. El análisis HEXACO mostró variaciones principalmente en los rasgos de apertura a la experiencia y emocionalidad. Los autores destacan que estas puntuaciones no equivalen a una evaluación psicométrica estandarizada, sino a una interpretación del contenido narrativo, y señalan como principal limitación que el estudio se basa únicamente en dos casos clínicos, por lo que plantean que investigaciones futuras con muestras más amplias permitan valorar con mayor solidez su utilidad clínica.

Fuente: Revista de Psicoterapia (Universitat de Barcelona), difundido por Infocop

Publicaciones científicas recientes

Scheerer, N. E., Rosenthal, M. Z., Birmingham, E., Carson, T. B., Van Esch, N., Williams, Z., Iarocci, G., & Jahn, K. N. (2026). Transdiagnostic mechanisms of decreased sound tolerance. *Nature Reviews Psychology*, 5(6), 402–419.

DOI: [10.1038/s44159-026-00565-y](https://doi.org/10.1038/s44159-026-00565-y)

Hallazgo: Un equipo internacional de investigadores revisa la evidencia disponible sobre la disminución de la tolerancia a los sonidos cotidianos, centrándose en dos de sus manifestaciones más frecuentes: la hiperacusia, una tolerancia reducida a sonidos de intensidad moderada que en algunos casos puede llegar a provocar dolor físico, y la misofonía, caracterizada por intensas respuestas emocionales, fisiológicas y conductuales ante sonidos específicos como masticar, respirar o hacer clic con un bolígrafo, cuya intensidad no depende del volumen sino del significado o contexto del sonido. Según los estudios analizados en la revisión, aproximadamente el 15 % de los adultos australianos de entre 45 y 70 años presenta hiperacusia, un estudio canadiense encontró una prevalencia del 17 % entre estudiantes universitarios, y en Estados Unidos el 4,6 % de los adultos cumple criterios de misofonía

clínica, con estimaciones en población general que oscilan entre el 2 % y el 18 % según el método de evaluación. En una muestra de niños y jóvenes con autismo, cerca del 90 % de las familias informó de que la disminución de la tolerancia a los sonidos constituía un problema crónico. Los autores señalan que ambas alteraciones comparten mecanismos con trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, TDAH, autismo y trastorno obsesivo-compulsivo, sin que exista todavía un marcador biológico único ni herramientas diagnósticas estandarizadas.

Implicación clínica: Los autores sugieren que un enfoque transdiagnóstico, centrado en los mecanismos compartidos entre trastornos y no únicamente en las categorías diagnósticas tradicionales, puede resultar más útil para comprender y tratar la hiperacusia y la misofonía. Plantean que avanzar hacia criterios diagnósticos consensuados y herramientas de evaluación más precisas podría facilitar una respuesta clínica más adecuada, dado que actualmente ni existen pruebas de referencia para el diagnóstico ni la misofonía figura en los principales manuales diagnósticos, aunque está siendo evaluada para su incorporación a la CIE.

Prioridades del día

Interpretar con cautela las cifras provisionales de suicidio

Puede ser relevante trasladar a pacientes y familiares, cuando el tema surja en consulta, que los datos provisionales del INE sobre suicidios podrían estar subestimados y que las cifras definitivas no se conocerán hasta diciembre, evitando así conclusiones prematuras sobre la evolución del fenómeno.

Explorar técnicas narrativas de autodistanciamiento en el seguimiento clínico

Puede ser útil valorar la incorporación de herramientas como la autocaracterización en momentos relevantes del proceso terapéutico, como apoyo complementario para observar cambios en la manera en que la

persona se narra a sí misma, sin sustituir a las medidas de evaluación clínica habituales.

Considerar un enfoque transdiagnóstico ante quejas de sensibilidad a sonidos cotidianos

Puede ser oportuno explorar la presencia de hiperacusia o misofonía en personas con ansiedad, TDAH, autismo o TOC, dado que estas alteraciones comparten mecanismos con dichos cuadros y actualmente carecen de herramientas diagnósticas estandarizadas.